# RSPAU DR. S. HARDJOLUKITO YOGYAKARTA

## LAPORAN PEMANTAUAN TERAPI OBAT (PTO) RAWAT INAP

Instalasi Farmasi Klinis • Bangsal Rawat Inap Merak (Kamar 314 / Bed 14A)

**Dokumen PTO Farmasi**
Periode Ranap: 14 s/d 18 Okt 2026
Tanggal Evaluasi: 18–19 Okt 2026

## I. PROFIL & DATA DEMOGRAFI PASIEN

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nama Pasien | **Ny. SUNARTI** | No. Rekam Medis | **00109480** |
| Tanggal Lahir / Usia | 18 November 1963 (62 th 10 bln) • Geriatri | Jenis Kelamin | Perempuan |
| Tinggi / Berat Badan | 156 cm / 60 kg (IMT: 24.65 kg/m$^2$) | Dokter Penanggung Jawab | dr. Raden Triyono Edhi Sulistiyanto, Sp.PD., FINASIM |
| Tanggal Masuk / Keluar | 14-10-2026 (20:45) • 18-10-2026 (14:00) | Riwayat Alergi Obat | **AMOKSISILIN & AMPISILIN (Gatal kemerahan)** |
| Diagnosis Utama | **Vomitus Profuse ec dalam pelacakan (suspek food intoxication / GEA)** | Diagnosis Sekunder | DM Tipe 2 dengan Hiperglikemia, Riw. Hipertensi, Hiponatremia & Hipokloremia ringan, Anorexia Geriatri, ISPA |
| Riwayat Penyakit Dahulu | DM Tipe 2, Hipertensi, Vertigo, Post-Op Phaco+IOL OS katarak komplikata (04/08/2026) | Riwayat Obat Rumah (RPO) | Amlodipin 10 mg 1x1, Clopidogrel 75 mg 1x1, Glimepirid 3 mg 1x1, Metformin 500 mg 1x1, Becom C 1x1, Betahistin 3x6 mg, Ibuprofen 2x400 mg (UGD 11/10) |

## II. ANALISIS KONDISI KLINIS & TANDA-TANDA VITAL (TTV)

| Parameter Vital | Target Normal | IGD (14/10) | H1 (15/10) | H2 (16/10) | H3 (17/10) | H4 / Pulang (18/10) | Evaluasi & Catatan Klinis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tekanan Darah (mmHg)** | < 130/80 (PERHI 2021) | **101/80** (90/60 kln) | 149/70 | 125/66 – 113/67 | 122/65 – 140/79 | **144/81** → 122/82 | Fase awal syok hipovolemik teratasi dengan NaCl 0.9%. TD |

| Parameter Vital | Target Normal | IGD (14/10) | H1 (15/10) | H2 (16/10) | H3 (17/10) | H4 / Pulang (18/10) | Evaluasi & Catatan Klinis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | kembali meningkat membuktikan perlunya antihipertensi dilanjutkan. |
| **Nadi (kali/menit)** | 60 – 100 | **105** (Takikardia) | 92 | 90 – 95 | 81 – 99 | 88 – 94 | Takikardia awal kompensasi dehidrasi membaik pasca rehidrasi. |
| **Frekuensi Nafas (x/mnt)** | 12 – 20 | **22** (Takipnea) | 20 | 20 | 20 | 20 | Takipnea ringan saat MRS membaik. |
| **Suhu Tubuh (°C)** | 36.5 – 37.5 | 36.0 | 36.5 | 36.2 – 36.4 | 36.0 – 36.5 | 36.0 – 37.5 | Afebris sepanjang perawatan. |
| **SpO2 (%)** | ≥ 95% | 96% | 96% | 95% – 98% | 98% – 99% | 99% | Saturasi oksigen stabil dengan udara ruangan. |
| **Keluhan Pasien** | Tidak ada | Muntah >10x, mual+++, batuk+ | Mual++, lemas, batuk+ | Muntah nihil, mual+, batuk+ | Mual berkurang, batuk (-) | **TAK (Minta Pulang)** | Keluhan saluran cerna dan batuk membaik secara klinis. |

## III. ANALISIS MENDALAM HASIL LABORATORIUM (TEMUAN, MASALAH, & PERBAIKAN)

| Pemeriksaan Lab | Nilai Rujukan | Hasil Pasien | Status | Analisis Patofisiologis & Implikasi Klinis Farmasi |
|---|---|---|---|---|
| **Ureum Darah** | 21 – 43 mg/dL | **57 mg/dL** | **TINGGI** | **Azotemia Prerenal / Acute Kidney Injury (AKI):** Penurunan perfusi renal berat akibat dehidrasi diperparah konsumsi **Ibuprofen 2x400 mg** (menghambat prostaglandin vasodilator renal arteriol aferen). **Kalkulasi Cockcroft-Gault:** CrCl = **30.69 mL/menit**. **Kalkulasi CKD-EPI 2021:** eGFR = **31.46** |

| Pemeriksaan Lab | Nilai Rujukan | Hasil Pasien | Status | Analisis Patofisiologis & Implikasi Klinis Farmasi |
|---|---|---|---|---|
| **Kreatinin Serum** | 0.6 – 1.1 mg/dL | **1.80 mg/dL** | **TINGGI** | **mL/min/1.73m²** (Stadium G3b). *Hal yang Salah / Harus Diperbaiki:* Metoklopramid harus diturunkan 50%. Metformin harus distop. **Tidak ada pemeriksaan ulang kreatinin sebelum pasien pulang**. |
| **Natrium (Na)** | 135.0 – 147.0 mmol/L | **127.36 mmol/L** | **RENDAH** | **Hiponatremia & Hipokloremia Hipovolemik:** Kehilangan elektrolit masif bersama asam lambung (HCl) dan cairan cerna. Diberikan infus NaCl 0.9% 20 tpm. *Hal yang Salah / Harus Diperbaiki:* **Elektrolit TIDAK PERNAH diperiksa ulang** pasca koreksi cairan untuk memverifikasi normalisasi. |
| **Klorida (Cl)** | 95.0 – 105.0 mmol/L | **87.75 mmol/L** | **RENDAH** | |
| **GDS Awal (14/10)** | < 200 mg/dL | **310 mg/dL** | **TINGGI** | **Kegagalan Kendali Glikemik Puasa Rawat Inap (Target PERKENI 2021: 140–180 mg/dL):** Meskipun dosis Novorapid dinaikkan bertahap (3x8 → 3x10 → 3x12 UI), kadar GDP pasien pada pagi hari justru naik signifikan (235 → 236 → **298 mg/dL**). *Penyebab Farmakologis (PERKENI Hal. 42 & 100):* Novorapid (insulin aspart) hanya bekerja 3–5 jam untuk mengontrol glukosa makan. Pasien **tidak mendapatkan insulin basal** untuk menekan produksi glukosa hepatik malam hingga pagi hari. *Hal yang Harus Diperbaiki:* Terapkan regimen **Basal-Bolus** sesuai Pedoman PERKENI 2021: tambahkan insulin basal (Glargine 8–10 unit malam). |
| **GDS H1 (15/10)** | < 200 mg/dL | **208 mg/dL** | **TINGGI** | |
| **GDP H2 (16/10)** | 70 – 115 mg/dL | **235 mg/dL** | **TINGGI** | |
| **GDP H4 (18/10)** | 70 – 115 mg/dL | **298 mg/dL** | **TINGGI** | |
| **Hemoglobin / Ht** | 11.7–15.5 / 35–47% | **11.6 g/dL / 33.9%** | **RENDAH** | Anemia normositik normokrom ringan. Cukup dimonitor berkala. |
| **SGOT / SGPT** | < 35 / < 34 U/L | **39 / 23 U/L** | SGOT ↑ ringan | Peningkatan ringan transient pasca dehidrasi. |

## IV. DAFTAR LENGKAP DRUG RELATED PROBLEMS (DRP) TERIDENTIFIKASI

### DRP 1: Dosis Berlebih pada Gangguan Ginjal (Metoklopramid IV 3x10 mg)

**PCNE C3.1 / P1.2**

CrCl 30.69 mL/menit membutuhkan reduksi dosis metoklopramid sebesar 50% (5 mg IV q8h atau 10 mg q12h; max 15 mg/hari) guna mencegah risiko Tardive Dyskinesia pada lansia. Karena muntah telah teratasi sejak 16/10, rekomendasikan **HENTIKAN terapi metoklopramid**.

### DRP 2: Duplikasi Antiemetik Inap (Metoklopramid IV + Domperidone PO)

**PCNE C1.3 / P2.1**

Keduanya adalah antagonis reseptor dopamin D2. Penggunaan bersamaan meningkatkan risiko pemanjangan interval QT dan aritmia fatal ventrikel. **Hentikan Domperidone oral.**

### DRP 3: Kegagalan Regimen Insulin Mengontrol GDP (Sesuai Pedoman PERKENI 2021)

**PCNE C1.4 / P1.2**

Sesuai **Pedoman PERKENI 2021 Halaman 100**, target glukosa ranap adalah 140–180 mg/dL, dan pemberian insulin bolus/sliding scale saja sangat tidak disarankan. Novorapid 3x12 UI tanpa basal gagal mengontrol GDP (298 mg/dL). Rekomendasikan regimen **Basal-Bolus**: tambahkan Insulin Glargine 8–10 unit malam.

### DRP 4: Indikasi Belum Diterapi (Batuk Berdahak Putih / ISPA)

**PCNE C1.1 / P1.2**

Pasien batuk berdahak sejak MRS tanpa terapi mukolitik. Berikan **Ambroxol 3 x 30 mg tablet** atau **N-Asetilsistein 3 x 200 mg kapsul** selama 3–5 hari.

### DRP 5: Penggunaan Obat Nefrotoksik Sebelumnya (Ibuprofen 2x400 mg pada Dehidrasi)

**PCNE C1.2 / P2.1**

NSAID memicu vasokonstriksi arteriol aferen dan AKI prerenal pada pasien lansia yang dehidrasi. Hindari NSAID, gunakan Parasetamol 500 mg prn bila perlu.

### ⚠ DRP 6: DUPLIKASI FATAL RESEP PULANG (Gavistal 3x10 mg + Domperidone 2x10 mg)

**MAJOR RESEP PULANG**

**Gavistal adalah Metoklopramid 10 mg.** Resep pulang meresepkan Metoklopramid 3x10 mg bersamaan dengan Domperidone 2x10 mg. Ini adalah duplikasi berbahaya kelas antagonis dopamin D2 pada pasien gagal ginjal moderat (CrCl 30,69 mL/mnt) dengan risiko aritmia jantung dan distonia/diskinesia tardif di rumah. **BATALKAN GAVISTAL DAN DOMPERIDONE.**

### ⚠ DRP 7: OMISSION TERAPI KRONIS SAAT PULANG (Amlodipin & Clopidogrel Tidak Diresepkan)

**MAJOR RESEP PULANG**

Tekanan darah pasien saat pulang mencapai 144/81 mmHg. Namun Amlodipin dan Clopidogrel tidak diresepkan kembali. **Mulai kembali Amlodipin 5–10 mg 1x1 pagi dan Clopidogrel 75 mg 1x1 pagi.**

### DRP 8: Kombinasi Terapi DM Pulang Berisiko Hipoglikemia Berat (Glikuidon + Novorapid 3x12 UI)

SAFETY ALERT

Penggantian ke Glikuidon sudah sangat tepat untuk fungsi ginjal (PERKENI Hal. 38 & 111). Namun menggabungkan Glikuidon dengan Novorapid dosis masif (36 UI/hari) berisiko fatal hipoglikemia di rumah. Sederhanakan: optimalkan Glikuidon 30 mg 1–2x/hari ac, atau ganti insulin prandial dengan basal malam dosis kecil.

### DRP 9: Polifarmasi Saluran Cerna Berlebih Saat Pulang (5 Macam Obat Lambung)

PCNE C1.3

Pasien dipulangkan dengan Antasida syr, Omeprazole 2x20 mg, Rebamipide 3x1, Domperidone 2x1, Gavistal 3x1. Cukup berikan Omeprazole 1 x 20 mg pagi selama 5–7 hari saja.

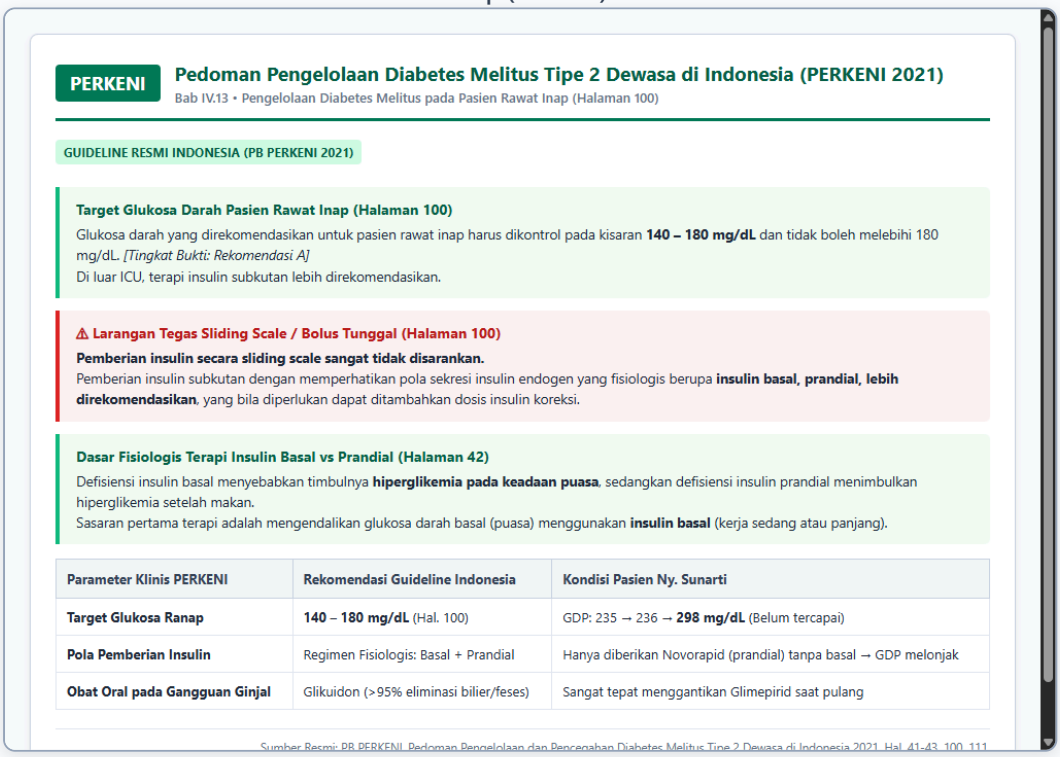
### DRP 10: Ketiadaan Pemantauan Laboratorium Kontrol Pasca-Tindakan

PCNE C3.5

Elektrolit (Na, Cl) dan Fungsi Ginjal (Ureum, Kreatinin) pasca koreksi cairan belum pernah diperiksa ulang sebelum pulang. Jadwalkan kontrol lab saat kontrol poli 1 minggu lagi.

## V. BUKTI GUIDELINE RESMI & PENYESUAIAN DOSIS TERKINI

BUKTI GUIDELINE 1: Pedoman Pengelolaan Diabetes Melitus Tipe 2 Dewasa PERKENI 2021 • Rawat Inap (Hal. 100)



PERKENI

**Pedoman Pengelolaan Diabetes Melitus Tipe 2 Dewasa di Indonesia (PERKENI 2021)**

Bab IV.13 • Pengelolaan Diabetes Melitus pada Pasien Rawat Inap (Halaman 100)

GUIDELINE RESMI INDONESIA (PB PERKENI 2021)

**Target Glukosa Darah Pasien Rawat Inap (Halaman 100)**

Glukosa darah yang direkomendasikan untuk pasien rawat inap harus dikontrol pada kisaran **140 – 180 mg/dL** dan tidak boleh melebihi 180 mg/dL. *[Tingkat Bukti: Rekomendasi A]*
Di luar ICU, terapi insulin subkutan lebih direkomendasikan.

**⚠ Larangan Tegas Sliding Scale / Bolus Tunggal (Halaman 100)**

**Pemberian insulin secara sliding scale sangat tidak disarankan.**
Pemberian insulin subkutan dengan memperhatikan pola sekresi insulin endogen yang fisiologis berupa **insulin basal, prandial, lebih direkomendasikan**, yang bila diperlukan dapat ditambahkan dosis insulin koreksi.

**Dasar Fisiologis Terapi Insulin Basal vs Prandial (Halaman 42)**

Defisiensi insulin basal menyebabkan timbulnya **hiperglikemia pada keadaan puasa**, sedangkan defisiensi insulin prandial menimbulkan hiperglikemia setelah makan.
Sasaran pertama terapi adalah mengendalikan glukosa darah basal (puasa) menggunakan **insulin basal** (kerja sedang atau panjang).

| Parameter Klinis PERKENI | Rekomendasi Guideline Indonesia | Kondisi Pasien Ny. Sunarti |
|---|---|---|
| **Target Glukosa Ranap** | **140 – 180 mg/dL** (Hal. 100) | GDP: 235 → 236 → **298 mg/dL** (Belum tercapai) |
| **Pola Pemberian Insulin** | Regimen Fisiologis: Basal + Prandial | Hanya diberikan Novorapid (prandial) tanpa basal → GDP melonjak |
| **Obat Oral pada Gangguan Ginjal** | Glikuidon (>95% eliminasi bilier/feses) | Sangat tepat menggantikan Glimepirid saat pulang |

Sumber Resmi: PB PERKENI. Pedoman Pengelolaan dan Pencegahan Diabetes Melitus Tipe 2 Dewasa di Indonesia 2021. Hal. 41-43, 100, 111

**Penerapan Klinis Guideline Indonesia:** Sesuai Pedoman PERKENI 2021 Bab IV.13 (Halaman 100), target glukosa darah rawat inap non-kritis adalah **140–180 mg/dL**. PERKENI secara tegas menyatakan: "*Pemberian insulin secara sliding scale sangat tidak disarankan. Pemberian insulin subkutan dengan memperhatikan pola sekresi insulin endogen yang fisiologis berupa insulin basal, prandial, lebih direkomendasikan.*"

## BUKTI GUIDELINE 2: Lexicomp Clinical Drug Information & FDA Label • Penyesuaian Dosis Metoklopramid pada Gangguan Ginjal

**Lexicomp / FDA**

### Metoclopramide (Gavistal) • Clinical Drug Information & FDA Label

Dosage Adjustments: Renal Impairment & Geriatric Safety Profile

**FDA WARNING: TARDIVE DYSKINESIA & EXTRA PYRAMIDAL SYMPTOMS (EPS)**

Treatment with metoclopramide can cause **tardive dyskinesia** and acute extrapyramidal reactions, which are often irreversible. The risk increases with duration of treatment, cumulative dose, **advanced age (geriatric patients, especially elderly females)**, and **renal impairment (impaired clearance)**. Avoid treatment for longer than 12 weeks. Discontinue immediately in patients who develop signs or symptoms of movement disorders.

#### Renal Impairment Dosage Adjustment Table

| Creatinine Clearance (CrCl) | Recommended Dosage Adjustment | Clinical Rationale & Risk |
|---|---|---|
| **CrCl ≥ 40 mL/min** | 100% of standard dose (No adjustment needed) | Normal renal elimination (~80% excreted in urine). |
| **CrCl 10 to < 40 mL/min (Patient: 30.69 mL/min)** | **Administer 50% of the recommended dose (e.g., 5 mg IV q8h or 10 mg q12h; Max 15 mg/day)** | **Overdose Alert: Patient received full dose 3x10 mg (30 mg/day). Clearance decreased by ~50%, leading to drug accumulation and severe EPS risk.** |
| **CrCl < 10 mL/min / ESRD** | Administer 25% to 50% of recommended dose | Severe accumulation risk. Avoid prolonged use. |

#### Clinical Pharmacist Recommendation for Ny. Sunarti

1. **Inpatient Phase:** Karena CrCl = 30.69 mL/menit, dosis Injeksi Metoklopramid seharusnya disesuaikan menjadi 5 mg IV q8h (50% reduksi). Karena muntah telah teratasi sejak 16/10, injeksi metoklopramid dihentikan.
2. **Discharge Phase:** Resep pulang tertulis *Gavistal (Metoklopramid) 10 mg tab 3x1*. Ini adalah dosis penuh tanpa penyesuaian ginjal dan harus **DIHENTIKAN** total.

Reference: FDA Prescribing Information for Reglan (Metoclopramide HCl) & Lexicomp Online Dosing in Renal Impairment, UpToDate, Wolters Kluwer 2024.

## BUKTI GUIDELINE 3: Drug Interaction & Duplication Alert • Gavistal (Metoklopramid) + Domperidone Co-Prescription

**DRP ALERT**

### Therapeutic Duplication & Drug Interaction Analysis

Gavistal® (Metoclopramide 10 mg) + Domperidone 10 mg Co-Prescription

**⚠ MAJOR CLINICAL DRP: PHARMACODYNAMIC DUPLICATION & ADDITIVE CARDIOTOXICITY**

Resep Pulang (18/10/2026) meresepkan **GAVISTAL 10 MG TAB 3x1** bersamaan dengan **DOMPERIDONE 10 MG TAB 2x1**. Gavistal mengandung Metoklopramid. Keduanya adalah antagonis reseptor dopamin D2. Penggunaan bersamaan meningkatkan risiko efek samping yang berpotensi fatal tanpa keuntungan terapeutik.

**Gavistal® (Metoclopramide HCl 10 mg)**

**Mekanisme:** Antagonis reseptor D2 dopamin sentral & perifer + agonis 5-HT4.
**Eliminasi:** Ginjal (~80%). Pada CrCl 30.69 mL/menit waktu paruh meningkat.
**Efek Toksik:** Sindrom ekstrapiramidal, distonia, akatisia, diskinesia tardif.

**Domperidone 10 mg**

**Mekanisme:** Antagonis reseptor D2 dopamin perifer.
**Eliminasi:** Hepatik (CYP3A4).
**Efek Toksik:** Pemanjangan interval QT ventrikel, aritmia jantung torsades de pointes, henti jantung mendadak (EMA Drug Safety Warning).

| Risk Rating / Severity | Clinical Consequences | Evidence-Based Action |
|---|---|---|
| **Category D / X** (Avoid Combination / Severe Risk) | 1. **Additive QT Prolongation:** Risiko fatal sudden cardiac death pada lansia wanita.<br>2. **Additive Neurotoxicity:** Peningkatan insiden kejang, distonia, atau agitasi.<br>3. **Hyperprolactinemia:** Blokade dopamin aditif pada sumbu hipofisis. | **HENTIKAN DUPLIKASI.**<br>Karena keluhan muntah pasien sudah tidak ada dan mual sudah teratasi, hentikan kedua obat ini saat pulang atau sisakan satu jenis saja bila perlu (prn). |

Reference: EMA Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) Recommendations on Domperidone & Metoclopramide Safety, Lexicomp Drug Interactions 2024.

BUKTI GUIDELINE 4: KDIGO 2023 & PERKENI Guidelines • Pemilihan Terapi Antidiabetes Oral pada Gangguan Ginjal

**KDIGO / PERKENI** **KDIGO 2023 & PERKENI Guidelines • Diabetes Management in CKD**

Safety Profiles & Renal Dosing of Oral Antidiabetic Drugs (OADs)

EVIDENCE-BASED RENAL SELECTION OF ANTIDIABETIC THERAPY

| Drug Class / Agent | eGFR / CrCl Threshold | Guideline Recommendation | Application to Ny. Sunarti (eGFR 31.46 / CrCl 30.69) |
|---|---|---|---|
| **Metformin** (Biguanide) | eGFR 30–44 mL/min/1.73m² eGFR < 30 mL/min/1.73m² | Dose reduction max 1000 mg/d; **Contraindicated** if <30. **HOLD during acute illness, vomiting, dehydration** due to risk of Lactic Acidosis (MALA). | **✓ TEPAT DIHENTIKAN saat MRS. Jangan dimulai kembali sebelum re-evaluasi fungsi ginjal pasca hidrasi.** |
| **Glimepiride** (Sulfonylurea) | eGFR < 60 mL/min/1.73m² | Metabolit aktif diekskresi melalui ginjal (~60%). Akumulasi metabolit memicu **hipoglikemia berat dan berkepanjangan**. | **✓ TEPAT DIGANTI saat pulang karena risiko akumulasi ginjal pada CrCl 30.69 mL/min.** |
| **Gliquidone (Glikuidon) (Sulfonylurea)** | **eGFR 15–60 mL/min/1.73m²** | **Eliminasi utama melalui bilier / feses (>95%); hanya <5% lewat ginjal. Tidak memerlukan penyesuaian dosis pada gangguan ginjal. OAD sulfonilurea pilihan pada nefropati.** | **Pilihan Tepat untuk Ginjal. Namun harus hati-hati jika digabung dengan insulin Novorapid 3x12 UI karena risiko hipoglikemia aditif.** |
| **Glikuidon + Novorapid 3x12 UI** | **Polifarmasi Antidiabetes Pulang** | **Kombinasi sulfonilurea + insulin bolus dosis tinggi (36 unit/hari) pada geriatri berisiko memicu fatal hipoglikemia, tanpa menyelesaikan hiperglikemia puasa (GDP).** | **PERLU TITRASI & REKOMENDASI: Evaluasi pemberian insulin basal malam dosis kecil daripada Novorapid dosis tinggi + Glikuidon.** |

Reference: KDIGO 2023 Clinical Practice Guideline for Diabetes Management in CKD & Pedoman Pengelolaan DM Tipe 2 Dewasa PERKENI 2021/2023.

BUKTI GUIDELINE 5: Konsensus PERHI 2021 & ACC/AHA • Target Tekanan Darah & Rekonsiliasi Obat Kronis Pulang

**PERHI / ACC-AHA** **Hypertension Guidelines & Hospital Medication Reconciliation**

Target Blood Pressure & Resumption of Withheld Chronic Therapies

**⚠ DISCHARGE MEDICATION RECONCILIATION OMISSION**

Pasien dengan riwayat hipertensi rutin minum **Amlodipin 10 mg 1x1** dan **Clopidogrel 75 mg 1x1**. Obat distop saat MRS karena dehidrasi (TD 90/60). Setelah normovolemia, TD pasien naik hingga 144/81 mmHg. Namun, pada resep pulang kedua obat kronis ini **TIDAK DIRESEPKAN KEMBALI**.

| Guideline Domain | Evidence-Based Standard | Clinical Recommendation for Ny. Sunarti |
|---|---|---|
| **Target Blood Pressure (PERHI 2021 / KDIGO 2021)** | Target TD pada pasien DM dengan nefropati / CKD adalah **< 130/80 mmHg** (atau < 140/90 mmHg pada lansia yang frail). | TD pasien 144/81 mmHg pada hari pemulangan (18/10) → belum mencapai target < 130/80 mmHg tanpa antihipertensi. |
| **Resumption of Amlodipine (10 mg → 5-10 mg)** | Re-evaluasi dan mulai kembali agen antihipertensi saat stabilitas hemodinamik tercapai sebelum pemulangan. | Mulai kembali **Amlodipin 5 mg atau 10 mg 1 x sehari** untuk mencegah hipertensi rebound dan melindungi target organ (jantung & ginjal). |
| **Resumption of Clopidogrel (75 mg 1x1)** | Antiplatelet untuk prevensi sekunder kardio/serebrovaskular harus dilanjutkan kecuali ada bukti perdarahan aktif. | Lanjutkan kembali **Clopidogrel 75 mg 1 x sehari**. Pasien tidak memiliki tanda perdarahan gastrointestinal (feses/urin normal, Hb stabil). |

Reference: Konsensus Penatalaksanaan Hipertensi PERHI 2021 & ACC/AHA Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure.

## VI. REKONSILIASI TERAPI PULANG YANG DIREKOMENDASIKAN

| Resep Pulang Aktual Dokter (IRJ-261018-87885) | Rekomendasi Rekonsiliasi Farmasis Klinis |
|---|---|
| 1. Antasida Sirup 3 x 1 C (10 mL) ac<br>2. Domperidone 10 mg tab 2 x 1 ac<br>3. **Gavistal (Metoklopramid) 10 mg tab 3 x 1 ac**<br>4. Glikuidon 30 mg tab 1 x 1 pagi ac<br>5. Novorapid Flexpen 3 x 12 UI ac (Jarum: 1 pcs)<br>6. Omeprazole 20 mg kap 2 x 1 ac<br>7. Rebamipide 100 mg tab 3 x 1 ac<br>**× Amlodipin & Clopidogrel TIDAK ADA** | 1. **Amlodipin 1 x 5–10 mg PO pagi:** Dimulai kembali (TD 144/81 mmHg, target <130/80 PERHI 2021).<br>2. **Clopidogrel 1 x 75 mg PO pagi:** Dimulai kembali untuk prevensi sekunder kardio/stroke.<br>3. **Glikuidon 1 x 30 mg PO pagi sebelum makan:** Dilanjutkan sebagai OAD aman ginjal (PERKENI Hal. 38 & 111).<br>4. **Evaluasi Insulin:** Jika asupan makan baik, optimalkan Glikuidon 30 mg (bisa 1–2x/hari). Jika butuh insulin, berikan insulin basal malam (Glargine 8–10 unit) daripada Novorapid 3x12 UI + Glikuidon.<br>5. **Omeprazole 1 x 20 mg PO pagi (1 jam ac):** Cukup 1 x sehari selama 5–7 hari saja.<br>6. **BATALKAN:** Gavistal (Metoklopramid), Domperidone, Antasida, dan Rebamipide. |

Yogyakarta, 19 Oktober 2026
**Apoteker Klinis Penelaah,**

RSPAU dr. S. Hardjolukito Yogyakarta
Unit Farmasi Klinis • Bangsal Rawat Inap Merak

**( Tim Farmasi Klinis / Apoteker Pendamping )**
SIP. Farmasi Klinis RSPAU Hardjolukito